Tipo do Documento	**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO**	Página 1/7	
Título do Documento	**PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO**	Emissão: 01/08/2026 Versão: 2	Próxima revisão: 01/08/2028

1. CONCEITO: Lesão por pressão é um dano localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo medico ou a outro artefato.

1.1 Responsáveis pela execução

Toda a equipe assistencial.

1.2 Finalidades

- Identificar e classificar os clientes com risco para LPP;
- Implementar ações preventivas nos clientes com risco para LPP;
- Identificar precocemente LPP em estágios iniciais.
- Realizar medidas de gestão da lesão, em caso de aparecimento de LPP;

1.3 Indicações

- Clientes hospitalizados adultos identificados com riscos para o desenvolvimento de LPP (escores nas escalas Braden ≤ 18 pontos);
- Destinado a adultos hospitalizados, que já encontram-se com lesão por pressão;

2. MATERIAIS

- Computador para realização do SCORE de BRADEN;
- Colchão piramidal;
- Coxins;
- Insumos para curativos;
- Creme barreira;

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

1. Avaliar a pele do paciente, durante a admissão, banho, e troca de fraldas diariamente;
2. Durante admissão e durante aparecimento de novas lesões, realizar preenchimento do historico de pele no sisitema MV.
3. Identificar e classificar o perfil de risco do cliente hospitalizado, na unidade para subsidiar os indicadores e as intervenções (antes e durante a internação).
4. Mudança de decubito a cada 3 horas, para setores de internação, e a cada 2 horas para unidade de tratamento intensivo (UTI);
5. Utilização de Coxins para elevação de proeminencia ósseas, bem como melhor reposicionamento do paciente, e descompressão de demais áreas de risco;
6. Divulgar a incidência de LPP e reavaliar as ações de prevenção, mensalmente.
7. Supervisionar o cumprimento das ações e promover capacitação contínua a equipe de enfermagem.
8. Registrar tipo de lesão, local e estadiamento, bem como, as ações de intervenção e de monitoramento.
9. Notificar as LPP's para a segrança do paciente através do QR code;
10. Notificar as LPPs desenvolvidas na instituição no NOTIVISA;

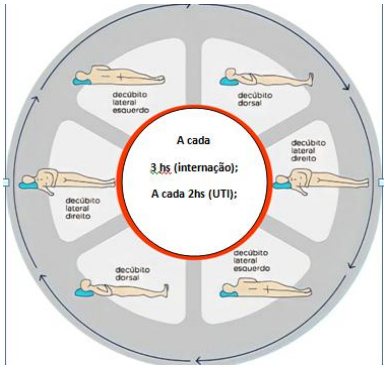
4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES

1. Intervenções – Clientes com baixo risco para LPP (15 a 18 pontos)
   - ✓ **Implementar protocolo assistencial para prevenção e tratamento de lesão por pressão.**

- Auxiliar a mudança de decúbito; - Estimular movimentação no leito; - Estimular movimentos ativos;	• Com alternância de posições de 3/3 horas; • Com exercícios com variação de movimentos. Orientá-lo a fazer os movimentos regularmente; • Realizando descompressão das áreas de risco;
Proporcionar posição confortável ao cliente	• em colchão hospitalar, com alinhamento postural e distribuição do peso.
Manter cabeceira elevada	• à 30º (considerando a altura do travesseiro), em posição semi-Fowler
Proteger a pele das proeminências ósseas S/N;	• de calcâneos, elevando-os acima da superfície da cama, com auxílio de um acolchoado sob a região posterior da perna , mantendo os joelhos levemente flexionados. • não utilizar almofadas tipo argola

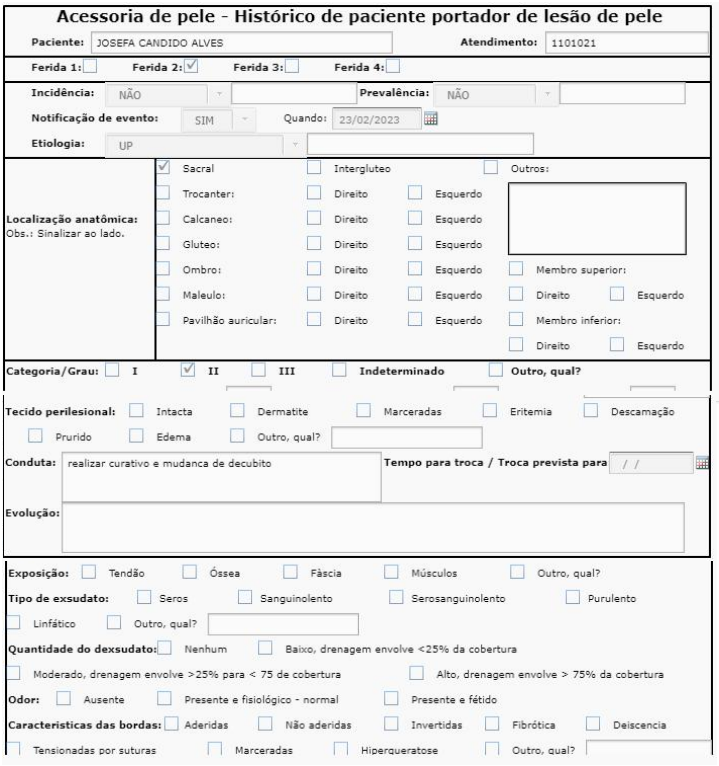
Realizar banho de leito - Realizar higiene corporal no chuveiro	• Utilizando sabonete hipoalergênico e água morna, sem massagear a pele sobre proeminências ósseas, 1 vez/dia.
Hidratar a pele	• sobre as proeminências ósseas com hidratante corporal à base de ácidos graxos essenciais (AGE), sem massagear. Reaplicá-lo a cada 6 horas (aprazamento ajustado as necessidades do cliente) • suspender o uso do produto, se o cliente apresentar sudorese intensa ou reações alérgicas. Comunicar e registrar.
- Implementar cuidados com eliminação urinária. - Realizar a higienização perineal após cada evacuação. - Aplicar barreiras de proteção com cremes e/ou absorventes de umidade	• Higienizar a pele com água e sabonete hipoalergênico. Secar e aplicar o (creme/fluido protetor cutâneo) nas regiões genital, inguinal e perianal. • Nas regiões genital, inguinal e perianal, após a higienização. Suspender o uso do (produto), se reações alérgicas. Comunicar e registrar.
Controlar a umidade da pele	• Avaliar e tratar os diferentes processos que podem originar excesso de umidade na pele: incontinência, sudorese excessiva, drenagens e exsudatos de feridas; • Realizar, após cada eliminação urinária ou fecal ou diante da presença da umidade na pele
Verificar o peso do paciente	• Comunicar ao nutricionista/médico, presença de perda de peso. • Colaborar no plano terapêutico do Nutricionista para estimativa de peso (quando não possível utilizar balanças).
Auxiliar o paciente a sentar na cadeira	• Sobre dispositivo almofadado e com os pés apoiados sobre uma banqueta, durante 2 horas, 2 a 3 vezes/dia. Retornar o cliente ao leito, em casos de hipotensão e outras inconformidades. • Orientar o cliente a suspender a região glútea, usando os braços da cadeira, pelo tempo que suportar, a cada 15 minutos. • Colaborar no plano terapêutico do fisioterapeuta.

Monitorar fontes de pressão e fricção da pele.	• Verificar se os lençóis da cama estão bem esticados, sem dobras ou costuras em contato com a pele. • Não deixar extensões de drenos/cateteres e outros sob o cliente.
Implementar cuidados com dieta por bomba de infusão.	• Seguir rigorosamente a vazão e horário prescritos.
Estimular ingestão hídrica.	• Quantificar a ingestão hídrica no formulário de controles. • Inspecionar sinais associados de desidratação (boca seca; olhos fundos; constipação/diarreia; pele/mucosas desidratadas e outros).
Inspecionar a pele em busca de pontos hiperemiados	•Edema, dor, tumefação (rigidez) e/ou bolhas, sobre as proeminências ósseas, a cada 6 horas (aprazamento ajustado as necessidades do cliente). Comunicar e registrar não conformidades.
Aferir sinais vitais	• De acordo com a rotina do setor ou necessidade para avaliação hemodinâmica. Comunicar e registrar não conformidades.
Avaliar a dor utilizando escala de intensidade (Registrar a dor como 5º sinal vital)	• Numérica • De fácies •Comportamental
- Interagir com o paciente. - Tranquilizar paciente. - Sentar e conversar com o paciente	• Registrar o resultado da intervenção. • Colaborar com o plano terapêutico do psicólogo.
- Orientar o paciente/familiar sobre sobre formas de adaptar-se as suas limitações - Estimular o autocuidado.	• Os cuidados de prevenção de LPP e mudanças de hábitos no domicílio, mediante entrega do folder de cuidados pós alta. • Colaborar no plano terapêutico do Assistente Social.
- Implementar cuidados com sonda nasoentérica. - Alternar local da passagem da sonda gástrica. - Implementar cuidados com a contenção mecânica. - Implementar cuidados com a traqueostomia. - Implementar cuidados com sondagem vesical de demora. - Implementar cuidados com dreno.	• Monitorar o posicionamento e presença de trações do (cateter/drenos/fixadores). • Observar a integridade da pele/mucosa e relatar não conformidades ao enfermeiro. • Alternar os locais de fixação do dispositivo. • Remover fitas adesivas com cuidado. • Proteger a pele com espuma fenestrada ou curativos específicos (ambos indicados para estomias, drenos,

<table>
<tr><td></td><td>cateteres e sondas).</td></tr>
<tr><td colspan="2">2. Clientes com Moderado Risco para LPP (escore de 13 a 14 pontos)
✓ Implementar protocolo assistencial para prevenção e tratamento de lesão por pressão incluindo as intervenções para clientes com baixo risco para LPP.</td></tr>
<tr><td>Realizar mudança de decúbito
 

Ribeiro ET AL, 2022.</td><td>• Lateral direito, dorsal, lateral esquerdo, de 3 em 3 horas ou conforme necessidade no caso de menor intervalo, ou no caso das UTI’s;
• Lateral inclinado a 30°, com dispositivos acolchoados (travesseiro ou trapézio de espuma de poliuretano e outros) entre as proeminências ósseas, com suporte para o braço e costas;
• Comunicar e registrar intolerâncias de posição e no aprazamento determinado.</td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Clientes com Alto e Muito Alto Risco para LPP (escore de ≤ 12)
✓ Implementar protocolo assistencial para prevenção e tratamento de lesão por pressão incluindo as intervenções para clientes com baixo e moderado risco para LPP</td></tr>
<tr><td>- Promover segurança e conforto
- Proporcionar posição confortável ao cliente</td><td>• Com colchões pneumáticos com fluxo alternado de ar.</td></tr>
<tr><td>Investigar com o paciente fatores que aliviam/pioram a dor como: posicionamento, aplicação de calor ou frio, repouso ou movimento, durante respiração profunda ou tosse.</td><td>• Comunicar ao enfermeiro não conformidades e registrar na evolução.</td></tr>
<tr><td>Avaliar a necessidade de administrar analgesia</td><td>• Identificar intensidade de dor, conforme prescrição e registrar.
• Após a execução do banho no leito, curativos, mudança de decúbito e outros Reavaliar a dor de 30 minutos a 1 hora após manejo Registrar o resultado no formulário de sinais vitais.</td></tr>
</table>

4. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS



Acessoria de pele - Histórico de paciente portador de lesão de pele

Paciente: JOSEFA CANDIDO ALVES **Atendimento:** 1101021

Ferida 1: ☐ **Ferida 2:** ☑ **Ferida 3:** ☐ **Ferida 4:** ☐

Incidência: NÃO **Prevalência:** NÃO

Notificação de evento: SIM Quando: 23/02/2023

Etiologia: UP

Localização anatômica: Obs.: Sinalizar ao lado.

☑ Sacral ☐ Intergluteo ☐ Outros:

☐ Trocanter: ☐ Direito ☐ Esquerdo

☐ Calcaneo: ☐ Direito ☐ Esquerdo

☐ Gluteo: ☐ Direito ☐ Esquerdo

☐ Ombro: ☐ Direito ☐ Esquerdo ☐ Membro superior: ☐ Direito ☐ Esquerdo

☐ Maleulo: ☐ Direito ☐ Esquerdo

☐ Pavilhão auricular: ☐ Direito ☐ Esquerdo ☐ Membro inferior: ☐ Direito ☐ Esquerdo

Categoria/Grau: ☐ I ☑ II ☐ III ☐ Indeterminado ☐ Outro, qual?

Tecido perilesional: ☐ Intacta ☐ Dermatite ☐ Marceradas ☐ Eritemia ☐ Descamação ☐ Prurido ☐ Edema ☐ Outro, qual?

Conduta: realizar curativo e mudanca de decubito **Tempo para troca / Troca prevista para** / /

Evolução:

Exposição: ☐ Tendão ☐ Óssea ☐ Fáscia ☐ Músculos ☐ Outro, qual?

Tipo de exsudato: ☐ Seros ☐ Sanguinolento ☐ Serosanguinolento ☐ Purulento ☐ Linfático ☐ Outro, qual?

Quantidade do dexsudato: ☐ Nenhum ☐ Baixo, drenagem envolve <25% da cobertura ☐ Moderado, drenagem envolve >25% para < 75 de cobertura ☐ Alto, drenagem envolve > 75% da cobertura

Odor: ☐ Ausente ☐ Presente e fisiológico - normal ☐ Presente e fétido

Caracteristicas das bordas: ☐ Aderidas ☐ Não aderidas ☐ Invertidas ☐ Fibrótica ☐ Deiscencia ☐ Tensionadas por suturas ☐ Marceradas ☐ Hiperqueratose ☐ Outro, qual?

ESTÁGIOS DA LESÃO POR PRESSÃO



Estágio I: *pele intacta com vermelhidão não branqueável de uma área localizada, usualmente sobre uma proeminência óssea.*

Estágio II: *perda parcial da espessura da pele, envolvendo epiderme, derme ou ambas. A úlcera é superficial e se apresenta clinicamente como uma abrasão, bolha ou cratera rasa.*

Estágio III: *perda da espessura total do tecido. A gordura subcutânea pode estar visível, mas não há exposição de ossos, tendões ou músculos.*

Estágio IV: *perda da espessura total do tecido com exposição de ossos, tendões ou músculos.*

Não pode ser classificada: *aquela com perda total de tecido e cujas bases estão cobertas por esfacelo e/ou escara (marrom, preta ou acastanhada) no leito da ferida.*

6. REFERÊNCIAS

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Protocolo para prevenção de úlcera por pressão. Ministério da Saúde/ Anvisa/ Fiocruz- Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponivel em: file:///C:/Users/seguranca.paciente/Downloads/PROTOCOLO%20ULCERA%20POR%20PRESS%C3%83O.pdf

Ribeiro, W.A.; dos Santos, L.C.A; Dias, L.L.C; Fassarela, B.P.A; Alves, A.L.N; Neves, K.C; do Amaral, F.S. Fatores de riscos para lesão por pressão x Estratégias de prevenção: Interfaces do cuidado de enfermagem no âmbito hospitalar. Revista Pró-UniverSUS. 2022 Jan./Jun.; 13 (1): 02-06. Disponível em: file:///C:/Users/seguranca.paciente/Downloads/3174+RPU+V13N1+PL.pdf

dos Santos Silva, J. M., dos Santos Gôveia, L., & dos Santos, T. S. (2022). Idosos internados em unidade de terapia intensiva: o enfermeiro frente à prevenção de lesão por pressão. *Research, Society and Development*, *11*(12), e566111234951-e566111234951.

Mendonça, P. K., Loureiro, M. D. R., Frota, O. P., & Souza, A. S. D. (2018). Prevenção de lesão por pressão: ações prescritas por enfermeiros de centros de terapia intensiva. *Texto & Contexto-Enfermagem*, *27*.

Gomes, R. K. G., de Moraes, M. H. M., de Freitas Maniva, S. J. C., & Holanda, R. E. (2018). Prevenção de lesão por pressão: segurança do paciente na assistência à saúde pela equipe de enfermagem. *Revista Expressão Católica Saúde*, *3*(1), 71-77.

Machado, L. C. L. R., de Lima Fontes, F. L., de Sousa, J. E. R. B., Neta, A. D. S. S., Alencar, E. J. C., da Costa, A. C. R. R., ... & Prudêncio, L. D. (2019). Fatores de risco e prevenção de lesão por pressão: aplicabilidade da Escala de Braden. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, (21), e635-e635.

Versão 1 - Elaboração Nayanne Ingrid Farias Mota Guerra	Data: 01/07/2025
Revisão Giulianna Carla **Validação** Claudio Emmanuel **Registro, análise e revisão final** Giulianna Carla Claudio Emmanuel **Aprovação** Claudio Emmanuel Sonia Delgado	Data: 01/08/2026